

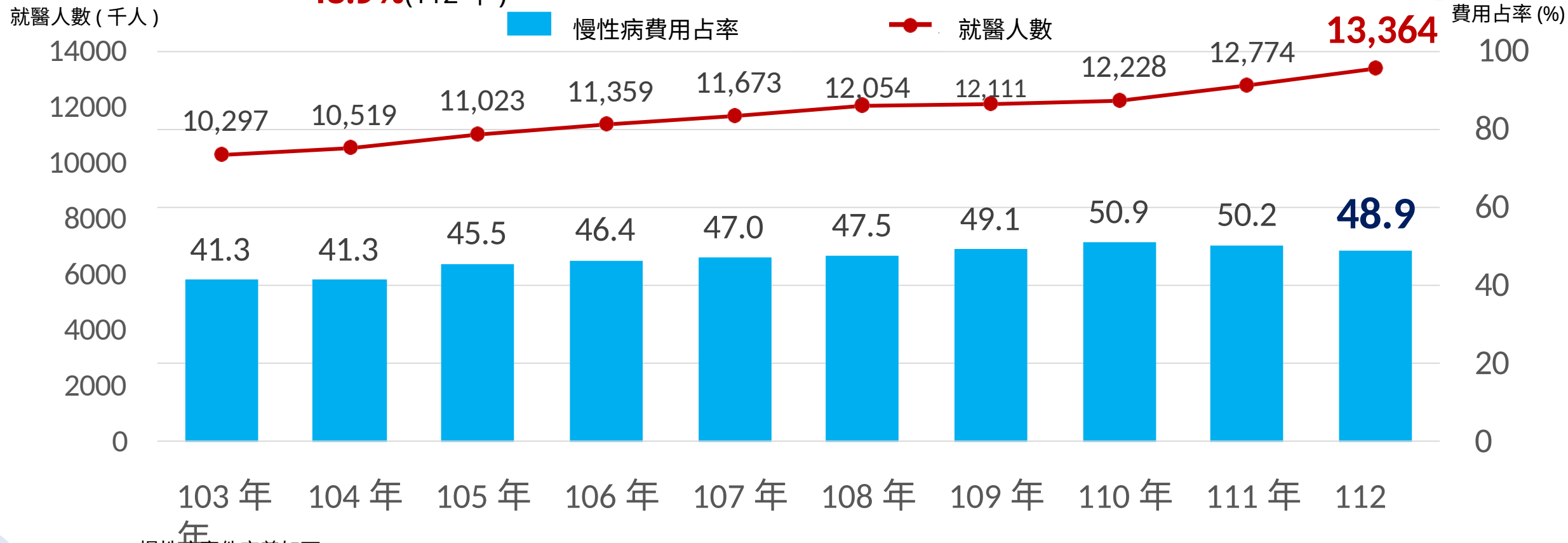


2

888 計畫 強化慢病

近十年慢性病就醫人數及費用占率

近十年慢性病就醫人數自 1,029.7 萬人 (103 年) 成長至 **1,336 萬人** (112 年) 慢性病費用占整體健保支出則自 41.3%(103 年) 成長至 **48.9%**(112 年)



慢性病案件定義如下：

1. 門診：案件分類為慢性病 (04,24)、透析 (05)、結核病 (06)、慢箋箋調劑 (08,28)、支付制度試辦計畫 (E1)、愛滋病慢箋 (E2,E3) 或開藥天數大於 14 日。

排除代辦案件斷為全數健保醫療費用辦法規定得請立慢箋之「全民健康保險慢性疾病範圍」

慢性病策略的「第 1 步」：888 計畫

三高防治 888 計畫——目標到 119 年 /2030 年達成：

1. 80% 找得到

○ 把 80% 三高病人找出來，納入照護網（例如大家醫計畫、全人全社區照護計畫等）。

2. 80% 要介入

○ 照護網內 80% 病人接受生活習慣評估與諮商，導入生活型態醫學，不只是「開藥」而已。

3. 80% 有改善

○ 透過長期追蹤與數位工具，讓 80% 收案病人達到三高穩定控制或明顯改善。

第一個創新：慢性病支付「整合化」 從單病 P4P 到「大家醫＋全人」

1. 家醫計畫 2.0 / 大家醫計畫

- 將原本分散的家庭醫師整合性照護計畫、代謝症候群防治計畫、糖尿病及初期慢性腎臟病照護方案（P4P DM/CKD/DKD），整合成一套慢性病照護架構，讓病人「在同一家院所就能完成多重慢病管理」。
- 目前約有 301 萬名三高個案（約 56%）納入家醫＋代謝＋P4P＋全人等共照網，目標是朝 80% 以上（超過 400 萬人）邁進。

2. 全人全社區照護計畫：專款制度

- 醫院總額中，切出專款推動「地區醫院全人全社區照護計畫」，明定是要把尚未加入任何慢病計畫的三高高風險病人，交給「主要就醫的地區醫院」來收案。
- 三高病人約 551 萬人，已被家醫、DM/CKD/DKD 等計畫收案約 316 萬人，其餘 234 萬人就是要由全人計畫來處理。

3. 支付方式從「論量」走向「論質＋論值」

- 不只是給基本管理費，還透過家醫計畫、全人計畫的品質指標評核與獎勵機制，把 HbA1c、LDL、血壓控制率、篩檢完成率等，把「結果」納入給付基礎。

第二個創新：照護網「分級化」——家醫 ＋全人成為 888 的骨幹

1. 家醫計畫：社區層級

- 截至 114 年底，家醫計畫已有 471 個醫療群、5,456 家診所參與，約 8,026 名醫師投入，收案約 647 萬人。
- 「忠誠會員」大量是高齡、三高、多重慢病病人，是第一層照護網。

2. 全人全社區照護：地區醫院做「第二層」

- 健保署直接從門診明細抓出尚未被收案的三高＋高 ASCVD 風險病人，指派給其「地區醫院」來收案。
- 計畫要求地區醫院必須與 1～2 家區域以上醫院＋5 家以上基層診所建立轉診與共同照護機制，把醫院、診所、社區串起來。

3. 888 策略下的「分級慢病藍圖」

- 「推動大家醫計畫，落實 888、檢討居家醫療，與長照 3.0 無縫銜接、發展在宅急症照護」，讓病人在社區就能獲得完整照護。

第三個創新：數位與 AI——用「家醫大平台」做下一步跳躍

1. 家醫大平台：把病人的健康軌跡看得一清二楚

- 健保署的「家醫大平台」是以個人健康紀錄（PHR）為核心，整合健保就醫資料、公費＋自費健檢資料，以及未來的數位工具數據，成為大家醫與全人計畫共同使用的後台。
- 平台已經設計出：
 - 可以查詢全人／家醫會員最近一次 HbA1c、LDL、血壓等檢驗資料，並看近三年趨勢圖；
 - 可以直接看到降血壓、降血糖、降血脂用藥紀錄；
 - 有生活型態評估雷達圖，把飲食、運動、睡眠等習慣視覺化。

2. AI 風險分級＋診所雲端轉型：

- 家醫大平台會結合 AI 風險分級模型，先從 ASCVD 與糖尿病做起，讓系統提醒醫師：誰可以在基層追蹤、誰應該轉診、誰需要加強衛教或調整藥物。
- 為了讓 AI 真的進得了診間，健保署同時推動「診所醫療資訊系統雲端轉型」，目標 4 年內讓 8 成以上基層診所及藥局完成雲端建置，這樣家醫大平台才能即時串接、互動。

3. 數位照護與「論值給付」結合

- 在大家醫／全人架構下，未來只要診所或醫院導入有實證效果的數位照護工具（例如血糖管理 APP、遠距監測、生活型態介入平台），就可以在 P4P 與評核制度中，反映在成效與獎勵上。

在這些制度創新之上：台灣慢性病策略的「下一步」三個方向

方向一：從「發病後治療」再前移到「疾病前期＋生活型態」
家醫醫療群、全人計畫和各位糖尿病團隊的門診，把「三高前期、糖尿病前期＋生活型態醫學」變成日常工作，而不是附屬活動。

方向二：從「單一病種」走向「多重慢病＋長照＋在宅照護」的一條路
從門診血糖控制，一路銜接到長照 3.0、居家醫療、在宅急症，讓糖尿病病人「少住院、少失能、可以在地安老」。

方向三：從「資料分散」走向「家醫大平台＋ AI 分級」的精準慢病管理
用平台來找出個案、控制不佳個案、複雜共病個案；善用 AI 提示，協助看診。